

薬剤	トネベジル (アリセプト)	カランタミン (レミニール)	リバスチグミン (リバスタッチ/イクセロン)	メマンチン (メマリー)
薬効分類	ChE阻害薬	ChE阻害薬 + nACh受容体増強	ChE + BuChE阻害薬	NMDA受容体拮抗薬
適応症	アルツハイマー型認知症（軽度～高度） レビー小体型認知症（適応あり）	アルツハイマー型認知症（軽度～中等度）	アルツハイマー型認知症（軽度～中等度）	アルツハイマー型認知症（中等度～高度）
用法・用量	1日1回（夕食後） 3→5→10 mgへ漸増	1日2回（食後） 8→16→24 mg 徐放製剤は1日1回	経皮パッチ 4.5→9→13.5→18 mg/日へ段階的増量	1日1回 5→10→15→20 mgへ過ごとに増量
主な副作用	悪心、下痢、徐脈、夢の鮮明化	消化器症状、徐脈、QT延長	皮膚炎、悪心、嘔吐、徐脈	めまい、便秘、精神症状（幻覚、不眠）
腎機能の影響	調整不要（重度時は慎重）	CrCl < 9 mL/minは禁忌 中等度では16 mg/日まで	調整不要（慎重投与）	CrCl < 40で最大10 mg×2回 重度は慎重投与
肝機能の影響	中等度以下：調整不要 重度：慎重投与	中等度：最大16 mg/日 重度：禁忌	調整不要（重度では慎重）	軽中等度：問題なし 重度：慎重投与
薬物代謝	CYP2D6, 3A4	CYP2D6, 3A4	エステラーゼ代謝（CYP非関与）	主に腎排泄（CYP非関与）
剤形の特徴	錠剤、OD錠、細粒、ゼリー	錠剤、徐放カプセル、内用液	貼付剤（1日1回）	錠剤、口腔内崩壊錠、細粒
薬物相互作用	CYP阻害薬（キニジン等）で↑	CYP阻害薬で↑、QT延長薬と併用注意	相互作用少ない	相互作用ほぼなし
投与上の注意点	徐脈、胃満痛、嚥下困難例での剤形選択	腎・肝機能評価を必ず実施	貼付部位のローテーション、皮膚症状に注意	精神症状悪化のリスク、てんかんに注意
併用可否	他のChE阻害薬との併用不可	他のChE阻害薬との併用不可	他のChE阻害薬との併用不可	ChE阻害薬との併用可（標準的併用療法）
国内承認適応症	アルツハイマー型認知症（軽度～高度） + DLB（2023年適応追加）	アルツハイマー型認知症（軽度～中等度）	アルツハイマー型認知症（軽度～中等度）	アルツハイマー型認知症（中等度～高度）
レビー小体型認知症（DLB）への使用	適応あり（国内承認）	適応外だが使用されることあり（エビデンスは限定的）	適応外。一部で使用されるが慎重	適応外
前頭側頭型認知症（FTD）への使用	効果乏しい／推奨されない 行動異常を悪化させる例あり	非推奨（むしろ悪化の可能性）	非推奨（刺激性や咽気の問題）	効果なし～悪化報告あり 脱抑制を助長する可能性あり
DLB使用時の注意点	幻視・注意障害の改善が期待されるが 徐脈・起立性低血圧に注意	幻覚・妄想が悪化する可能性あり QT延長との関連に注意	パーキンソン症状の悪化報告あり 皮膚反応も加わるためDLBでは使いにくい	幻視・妄想が悪化する可能性あり DLBでは原則非推奨
FTD使用時の注意点	ChE阻害薬により脱抑制や興奮が悪化する可能性あり	同左	同左	NMDA遮断により行動障害が顕著する可能性
DLBへの使用	第一選択薬（適応あり）	使用可（適応外）だが慎重に	あまり推奨されない	原則非推奨
FTDへの使用	効果乏しい・非推奨	非推奨	非推奨	非推奨
認知症タイプ	主要症状	第一選択薬	治療上の注意点	
アルツハイマー型	記憶障害、見当識障害、実行機能障害	バジル、カランタミン、リバスチグミン、メマ	段階的増量、副作用（徐脈、消化器症状）に注意	
レビー小体型（DLB）	幻視、注意障害 パーキンソニズム、自律神経症状	トネベジル（承認あり）	起立性低血圧・徐脈、幻覚・妄想の増悪に注意	
前頭側頭型（FTD）	脱抑制、人格変化、行動異常、常同行動	薬物療法より環境調整・非薬物療法が中心	ChE阻害薬・メマンチンは非推奨、行動悪化の恐れ	